

Схема 3. Догоспитальное обследование: три параллельных потока

выполняются одновременно, что сокращает срок подготовки с 3–4 месяцев до 3–6 недель

Лабораторные исследования

Общий анализ крови, общий анализ мочи

Биохимия: белок, альбумин, АЛТ, АСТ, билирубин, креатинин с расчётом СКФ, мочевины, мочевого азота

Липидный спектр; глюкоза натощак, HbA1c, инсулин, С-пептид, индекс HOMA-IR

ТТГ, свободный Т4, АКТГ, кортизол суточной мочи, пролактин, тестостерон (у мужчин)

Ферритин, железо, витамин В12, фолаты, витамин D, кальций, паратгормон

Коагулограмма, группа крови и резус-фактор, маркёры гемотрансмиссивных инфекций

Инструментальные исследования

ЭГДС с биопсией и тестом на H. pylori

ЭКГ, эхокардиография

УЗИ органов брюшной полости и почек; эластометрия (фиброскан) печени

УЗИ вен нижних конечностей

Рентгенография органов грудной клетки, спирометрия

УЗИ органов малого таза (у женщин)

Консультации специалистов

Врач-куратор (терапевт) — координация маршрута и допуск к операции

Эндокринолог — коррекция СД 2 типа и иной эндокринной патологии

Кардиолог — оценка сердечно-сосудистого риска

Гастроэнтеролог — ГЭРБ, НАЖБП, H. pylori

Психиатр-психотерапевт — расстройства пищевого поведения, мотивация

Диетолог, гинеколог (у женщин), анестезиолог-реаниматолог

Дополнительно по показаниям:

пероральный глюкозотолерантный тест · суточное мониторирование АД · холтеровское мониторирование ЭКГ · стресс-эхокардиография при подозрении на ИБС · ночная пульсоксиметрия и полисомнография при подозрении на СОАС · денситометрия · КТ органов брюшной полости · консультации сомнолога, нефролога, ортопеда, сосудистого хирурга

Все результаты собирает и контролирует врач-куратор; объём обследования корректируется индивидуально

Ориентировочная длительность этапа — 3–6 недель; сроки годности исследований отслеживает медицинская организация, а не пациент